

Gastrit, Peptik Ülser ve H. pylori

Çocuk ve ergende üst gastrointestinal semptomlarda endoskopik tanı, H. pylori eradikasyonu, NSAİİ ilişkili ülser ve izlemin dozlu, kanıta dayalı karar çerçevesi.

Endoskopik tanı

H. pylori eradikasyonu

NSAİİ ülser

PPI dozları

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Gastrit histopatolojik bir tanıdır; klinik olarak "dispepsi" ile karıştırılmamalıdır. Peptik ülser, muskularis mukozayı aşan mide/duodenum mukoza defektidir. Çocukta primer (H. pylori, idiyopatik) ve sekonder (NSAİİ, stres, kritik hastalık, hipersekresyon) ülserler ayırt edilmelidir. İlk değerlendirmede amaç, ampirik tedaviye uygun fonksiyonel dispepsiyi organik/alarm bulgulu tablodan ayırmaktır.

Öykü

- Epigastrik ağrı: süre, ritim, geceleri uyandırma, öğünle ilişki (Rome IV fonksiyonel dispepsi kriterleri).
- NSAİİ, ibuprofen, aspirin, kortikosteroid, düşük molekül ağırlıklı ilaç kullanımı ve süre.
- Hematemez, melena, kilo kaybı, tekrarlayan kusma, disfaji sorgusu.
- Ailede peptik ülser, H. pylori, mide kanseri, MEN-1/gastrinoma öyküsü.
- Demir eksikliği anemisi, büyümede duraklama, kronik ilaç maruziyeti.

Muayene

- Persentil ve büyüme eğrisi; kilo/boy kaybı organik hastalık işareti.
- Solukluk, taşikardi, ortostatik değişiklik (gizli/aşıkâr kanama).
- Epigastrik hassasiyet, guarding, kitle; hepatosplenomegali.
- Perianal muayene ve gaitada gizli kan; ekstraintestinal İBH bulguları.
- Ağız içi aft, çomak parmak, cilt bulguları (sistemik hastalık ipuçları).

Rome IV'e uyan, alarm bulgusu olmayan fonksiyonel dispepside test-tedavi ("test and treat") stratejisi çocukta ÖNERİLMEZ; endoskopi kararı klinik ve alarm bulgularına dayanır.

Pediyatrik gastrit/ülser etiyolojisi, mukozal savunma ile agresif faktörler arasındaki dengenin bozulmasıdır. Başlıca kategoriler ve mekanizmaları aşağıdadır.

H. pylori

- Antral yerleşimli kronik aktif gastrit.
- Üreaz, VacA/CagA ile mukoza hasarı.
- Duodenal ülserle güçlü ilişki.

NSAİİ / ilaç

- COX-1 inhibisyonu, prostaglandin azalması.
- Mukus-bikarbonat bariyeri bozulur.
- Sıklıkla gastrik, çok odaklı.

Stres / kritik hastalık

- Splanknik hipoperfüzyon, iskemi.
- YBÜ, sepsis, yanık, kafa travması.
- Akut eroziv gastrit, kanama riski.

Hipersekresyon

- Zollinger-Ellison / gastrinoma.
- Sistemik mastositoz, kısa barsak.
- Tekrarlayan, tedaviye dirençli ülser.

İmmün / eozinofilik

- Crohn'un üst GİS tutulumu.
- Eozinofilik gastrit, otoimmün gastrit.
- Çölyak ile ilişkili lenfositik gastrit.

İdiyopatik / diğer

- H. pylori-negatif, NSAİİ-negatif ülser.
- Portal hipertansif gastropati.
- Safra reflüsü, kostik, viral (CMV/HSV).

03 Karar akışı

Üst GİS semptomlu çocukta endoskopi ve tedavi kararı, alarm bulguları ve etiyolojik ipuçlarına göre yönlendirilir.

BAŞLANGIÇ

Kronik/tekrarlayan epigastrik ağrı, dispepsi

Öykü, muayene, büyüme değerlendirmesi; ilaç ve NSAİİ sorgusu.

ADIM 1

Temel tetkik

Tam kan, ferritin, CRP, transaminaz, çölyak serolojisi; gaitada gizli kan.

KARAR 1

Alarm bulgusu var mı?

Kanama, kilo kaybı, disfaji, gece ağrısı, anemi, kitle, ısrarlı kusma.

EVET → Endoskopi endikasyonu

HAYIR → Rome IV değerlendir

ENDOSKOPI

Üst GİS endoskopisi + biyopsi

Antrum ve korpustan biyopsi (histoloji + hızlı üreaz + kültür/duyarlılık). Ülser görülürse etiyoloji araştır.

FONKSİYONEL

Fonksiyonel dispepsi yönetimi

4-8 hafta PPI denemesi, tetikleyicilerin düzenlenmesi; yanıtızsız/nüksde endoskopiye yeniden değerlendir.

KARAR 2

Endoskopide/biopsiye H. pylori pozitif mi?

Tanı, kültür veya histoloji + ikinci pozitif testle (hızlı üreaz) konur.

EVET → Duyarlılığa göre eradikasyon

HAYIR → Sekonder neden ara

ERADİKASYON

14 gün rejim, duyarlılığa göre

Antibiyotik duyarlılığı biliniyorsa hedefe yönelik; bilinmiyorsa yüksek doz üçlü/bizmutlu dördlü. Bölüm 06'ya bakınız.

SEKONDER

NSAİİ kes, PPI başla, hipersekresyon dışla

NSAİİ ilişkiliyse ilacı kes + PPI. Dirençli/çok odaklı ülserde serum gastrin ile ZES araştır.

Tanı, non-invaziv testlerle "tara-tedavi et" yerine, endoskopik doğrulamaya dayanır. Sıralı yaklaşım aşağıdadır.

H. pylori ve peptik hastalıkta basamaklı tanı yaklaşımı		
BASAMAK	TETKİK / EŞİK	NOT
Basamak 1 — Laboratuvar	Tam kan, ferritin, CRP/sedim, transaminaz, çölyak serolojisi	Demir eksikliği anemisi ve inflamasyon organik hastalığı işaret eder.
Basamak 2 — Endoskopi	Üst GİS endoskopisi (tanının temeli)	Alarm bulgusu veya dirençli semptomda ilk invaziv adım; ülser/erozyon doğrudan görülür.
Basamak 3 — Biyopsi	Antrum x2 + korpus x2 histoloji; hızlı üreaz testi	H. pylori tanısı için histoloji + ikinci pozitif test gerekir; PPI 2 hafta, antibiyotik 4 hafta önce kesilmeli.
Basamak 4 — Kültür/duyarlılık	Biyopside kültür + antibiyotik duyarlılık (veya moleküler direnç)	Klaritromisin/metronidazol direnci arttığından eradikasyon öncesi önerilir.
Basamak 5 — Non-invaziv izlem	Üre nefes testi (UBT) veya gaita antijen testi	Yalnızca eradikasyon sonrası kontrol için; primer tanıda tek başına yeterli DEĞİL.
Basamak 6 — Seçili durumlar	Açlık serum gastrin, gerektiğinde sekretin testi	Çoklu/dirençli ülser, diyare, MEN-1 kuşkusunda ZES için.

Eradikasyon sonrası kontrol tedavi bitiminden en az 4 hafta ve PPI kesildikten en az 2 hafta sonra yapılmalı; serolojik (antikor) test tedavi başarısını göstermez.

Aşağıdaki bulgular acil/erken endoskopi ve organik hastalık araştırmasını zorunlu kılar.

- Hematemez, kahve telvesi kusma veya melena

- Açıklanamayan kilo kaybı veya büyümede duraklama

- Demir eksikliği anemisi veya gaitada gizli kan pozitifliği

- Disfaji, odinofaji veya ısrarlı/safralı kusma

- Uykudan uyandıran gece ağrısı, sırta yayılım

- Epigastrik kitle, hepatosplenomegali veya sarılık

- Hemodinamik instabilite: taşikardi, hipotansiyon, solukluk

- Tedaviye dirençli/nükseden ülser (ZES, Crohn kuşkusu)

Asit baskılama PPI ile yapılır; *H. pylori* eradikasyonu duyarlılığına göre 14 gün, tercihen yüksek doz rejimlerle uygulanır. Dozlar mg/kg + maksimum olarak verilmiştir.

Asit baskılama ve destek tedavi dozları		
İLAÇ	DOZ	NOT
Omeprazol (PPI)	1-2 mg/kg/gün, bölünmüş 1-2 doz (maks 40 mg/gün)	Ülser 4-8 h önce
Lansoprazol	1-2 mg/kg/gün (maks 30 mg/gün)	PPI erad rejim kulla
Esomeprazol	10 mg (<20 kg) / 20 mg (≥20 kg) günde 1-2 (maks 40 mg/gün)	Kilo erad yüks edili
Ranitidin (H2RA, bulunursa)	4-8 mg/kg/gün, bölünmüş 2 doz (maks 300 mg/gün)	Çoğ piya çekil fame edili
Famotidin	0,5-1 mg/kg/gün, bölünmüş 2 doz (maks 40 mg/gün)	PPI kont edile
Sükralfat	40-80 mg/kg/gün, bölünmüş 4 doz (maks 4 g/gün)	Muk koru ilaçla veril

H. pylori eradikasyon rejimleri (14 gün) — ESPGHAN/NASPGHAN 2017

REJİM / İLAÇ	DOZ

REJİM / İLAÇ	DOZ
Yüksek doz üçlü (duyarlı) — PPI	1-2 mg/kg/gün, 2 doz (maks 40 mg/gün)
+ Amoksisilin	50 mg/kg/gün, 2 doz (maks 2 g/gün)
+ Klaritromisin	20 mg/kg/gün, 2 doz (maks 1 g/gün)
Metronidazol (klaritromisin direncinde)	20 mg/kg/gün, 2 doz (maks 1 g/gün)
Bizmutlu dörtlü (direnç/bilinmiyor) — Bizmut	8 mg/kg/gün (maks 480 mg/gün)
Yüksek doz ikili (kurtarma) — Amoksisilin	75 mg/kg/gün, 3-4 doz (maks 3 g/gün) + yüksek doz

Klaritromisin veya metronidazol, duyarlılık bilinmeden ampirik olarak KULLANILMAMALIDIR; bölgesel direnç yüksekse kültür-rehberli tedavi veya bizmutlu dörtlü tercih edilir. Tedaviye uyum eradikasyon başarısının en güçlü belirleyicisidir.

Süre: 14 gün

Duyarlılık rehberli

Yüksek doz PPI + amoksisilin

NSAİİ kes

Amaç eradikasyonu doğrulamak, ülser iyileşmesini teyit etmek ve nüksü/komplikasyonu önlemektir.

Eradikasyon ve iyileşme kontrolü

- Eradikasyon başarısı, tedaviden ≥ 4 hafta ve PPI kesiminden ≥ 2 hafta sonra UBT veya gaita antijen testiyle doğrulanır.
- Komplike ülser (kanama, perforasyon), dev/malign kuşkulu veya persistan semptomda kontrol endoskopisi yapılır.
- Duodenal ülserde PPI 4-8 hafta, gastrik ülserde 8 haftaya dek sürdürülür.
- Eradikasyon başarısızsa ilk rejimde kullanılmayan antibiyotiklerle, duyarlılık rehberli ikinci basamak seçilir.

Nüks önleme ve destek

- NSAİİ ilişkili ülserde ilaç kesilir; gerekiyorsa en düşük dozda + PPI gastroproteksiyonu ile devam.
- Demir eksikliği anemisi eşlik ediyorsa oral demir replasmanı ve yanıt takibi.
- Dirençli/nükseden ülserde ZES (serum gastrin), Crohn ve eozinofilik gastrit yeniden değerlendirilir.
- Aile içi reenfeksiyon kaynağı ve uyum; başarısız eradikasyonda uyum ve direnç birlikte gözden geçirilir.
- Fonksiyonel dispepside gereksiz uzun PPI kullanımından kaçınılır, semptom-yönelimli izlem yapılır.

Eradikasyon sonrası reenfeksiyon çocukta düşüktür; rutin seri tarama önerilmez. Kontrol testi negatifse ve semptom yoksa ek izlem gerekmez.

Kaynaklar

1. Jones NL, Koletzko S, Goodman K, ve ark. Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of *Helicobacter pylori* in Children and Adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(6):991-1003.
2. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, ve ark. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.

3. Kotilea K, Bontems P, Iwanczak B, ve ark. Management of Helicobacter pylori infection in children and adolescents. Helicobacter. 2023 (güncel derleme).
4. Levine A, Koletzko S, ve ark. ESPGHAN üst GİS endoskopi ve pediatrik peptik hastalık yönetim önerileri.

Uyarı: Bu belge klinik karar desteği amaçlıdır ve pediatrik gastroenteroloji uzmanı hekimin bireysel klinik değerlendirmesinin yerine geçmez. Dozlar hastanın yaşı, kilosu, böbrek/karaciğer işlevi ve yerel direnç paternlerine göre teyit edilmelidir.